



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PANDUAN
PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN
2025**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 1083.7/I-PND/DIR/XII/2025

Tentang
Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran

Disusun oleh :
Penanggung jawab BAB HPK



Fadhila Ayu Setyani, S.Kep.,Ns

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Ditetapkan oleh :
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan Rumah Sakit Prima Husada.

Panduan Persetujuan tindakan kedokteran ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi hak-hak pasien dan kewajiban pasien dan keluarga sesuai dengan undang-undang dan pelayanan di rumah sakit.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan panduan ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Panduan Persetujuan Tindakan Kedokteran ini, pelayanan Rumah Sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Malang, 01 Desember 2025

PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes

TIM PENYUSUN

Pengarah dan Editor:

Dr. dr. Aslichah, M. Kes.,AFP

Penyusun:

- 1. Puput Sekar Nari Ratih, Amd.Keb.,SE
- 2. Fadhila Ayu Setyani, S.Kep.,Ns
- 3. Amilatul Kholifah, Amd.Kep
- 4. Ns. Nazhilatul Rizkia, S. Tr. Kep

DAFTAR ISI

Sampul i

Lembar Pengesahan i

Kata Pengantar i

Tim Penyusun i

Daftar Isi i

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ii

Bab I Pendahuluan 1

 1.1 Latar Belakang **Error! Bookmark not defined.**

 1.2 Maksud Dan Tujuan **Error! Bookmark not defined.**

 1.3 Ruang Lingkup **Error! Bookmark not defined.**

 1.4 Pengertian **Error! Bookmark not defined.**

Bab II Ketentuan 3

 2.1 Penggunaan Persetujuan Tertulis 3

 2.2 Isi Persetujuan Tindakan 3

 2.3 Persetujuan Dan Penjelasan Tindakan Kedokteran 4

 2.4 Yang Berhak Memberikan Persetujuan 4

 2.5 Ketentuan Pada Situasi Khusus 4

 2.6 Penolakan Tindakan Kedokteran 5

 2.7 Masa Berlaku Persetujuan Tindakan Kedokteran 5

Bab III Tata Laksana 6

 3.1 Pemberian Informasi Kepada Pasien 6

 3.2 Cara Pemberian Informasi 6

 3.3 Penyampaian Keputusan 7

Bab IV Penutup 10



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 1083.7/I-PND/DIR/XII/2025

TENTANG
PANDUAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

- Menimbang : a. bahwa keterbatasan kemampuan pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka untuk memenuhi kebutuhan pasien diperlukan rujukan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Panduan Rujukan Pasien;
- Mengingat : (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
(2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan;
(3) Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit;
(4) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;
(5) Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 233.10/DPM/I-KEP/DIR/IV/2026 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
(6) Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor 838.1/I-KEP/DIR/IX/2025 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA TENTANG PANDUAN PERSETUJUAN TINDAKAN KEDOKTERAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Rumah Sakit ini yang dimaksud dengan:

- (1) Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
- (2) Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.
- (3) Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.
- (4) Tindakan Invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
- (5) Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.
- (6) Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran



gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.

Pasal 2

- (1) Setiap tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi harus memperoleh persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh yang berhak memberikan persetujuan.
- (2) Tindakan kedokteran yang tidak termasuk dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dapat diberikan dengan persetujuan lisan.
- (3) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk pernyataan yang tertuang dalam formulir khusus yang dibuat untuk itu.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dalam bentuk ucapan setuju atau bentuk Gerakan menganggukkan kepala yang dapat diartikan sebagai ucapan setuju.
- (5) Dalam hal persetujuan lisan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap meragukan, maka dapat dimintakan persetujuan tertulis.

Pasal 3

- (1) Dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa pasien dan/atau mencegah kecacatan tidak diperlukan persetujuan tindakan kedokteran.
- (2) Keputusan untuk melakukan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh dokter atau dokter gigi dan dicatat di dalam rekam medik.
- (3) Dalam hal dilakukannya tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dokter atau dokter gigi wajib memberikan penjelasan sesegera mungkin kepada pasien setelah pasien sadar atau kepada keluarga terdekat.

Pasal 4

- (1) Ada regulasi tentang hak pasien untuk mendapatkan informasi tentang kondisi, diagnosis pasti, rencana asuhan, dan dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan serta diberitahu tentang hasil asuhan termasuk kemungkinan hasil yang tidak terduga.
- (2) Pasien diberi informasi tentang kondisi medis mereka dan diagnosis pasti.
- (3) Pasien diberi informasi tentang rencana asuhan dan tindakan yang akan dilakukan dan berpartipasi dalam pengambilan keputusan.
- (4) Pasien diberi tahu bilamana "persetujuan tindakan" (*informed consent*) diperlukan dan bagaimana proses memberikan persetujuan.
- (5) Pasien dijelaskan dan memahami tentang hasil yang diharapkan dari proses asuhan dan pengobatan.



- (6) Pasien dijelaskan dan memahami bila terjadi kemungkinan hasil yang tidak terduga.
- (7) Pasien serta keluarga dijelaskan dan memahami tentang haknya dalam berpar sipasi membuat keputusan terkait asuhan jika diinginkan.

Pasal 5

- (1) Ada regulasi yang dijabarkan dengan jelas mengenai persetujuan khusus (*informed consent*).
- (2) DPJP menjelaskan informasi tindakan yang akan diambil dan bila perlu dapat dibantu staf terlatih.
- (3) Pasien memahami informasi tindakan yang memerlukan persetujuan khusus (*informed consent*) melalui cara dan bahasa yang dimengerti oleh pasien. Pasien dapat memberikan/menolak persetujuan khusus (*informed consent*) tersebut.

Pasal 6

- (1) Persetujuan khusus (*informed consent*) harus diperoleh sebelum pasien operasi atau prosedur invasif, sebelum anestesi (termasuk sedasi), pemakaian darah dan produk darah, serta pengobatan risiko tinggi lainnya.
- (2) Persetujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 harus tercatat dalam rekam medis
- (3) Identitas DPJP dan orang yang membantu memberikan informasi kepada pasien serta keluarga dicatat di rekam medik pasien.

Pasal 7

- (1) Persetujuan tindakan kedokteran dapat dibatalkan atau ditarik kembali oleh yang memberi persetujuan sebelum dimulainya tindakan.
- (2) Pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara tertulis oleh yang memberi persetujuan.
- (3) Segala akibat yang timbul dari pembatalan persetujuan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) menjadi tanggung jawab yang membatalkan persetujuan.

Pasal 8

- (1) Penjelasan tentang tindakan kedokteran harus diberikan langsung kepada pasien dan/atau keluarga terdekat, baik diminta maupun tidak diminta.
- (2) Dalam hal pasien adalah anak-anak atau orang yang tidak sadar, penjelasan diberikan kepada keluarganya atau yang mengantar.

Pasal 9

- (1) Rumah sakit menyusun daftar semua pengobatan/ tindakan/ prosedur yang memerlukan persetujuan khusus
- (2) Daftar semua pengobatan/ tindakan/ prosedur yang memerlukan persetujuan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1 adalah:
 - a. tindakan pembedahan atau Tindakan Invasif



- b. tindakan pembiusan
- c. tindakan pemberian produk darah/ transfusi
- d. tindakan pemberian elektrolit pekat
- e. pemasangan alat (NGT, Kateter, C-pap, Ventilator)

Pasal 10

- (1) Ada regulasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang menetapkan proses dan siapa yang menandatangani persetujuan khusus (*informed consent*) bila pasien tidak kompeten.
- (2) Rumah sakit menetapkan dan melaksanakan proses apabila orang lain yang memberi persetujuan khusus (*informed consent*)
- (3) Nama orang yang menggantikan pemberi persetujuan dalam persetujuan khusus (*informed consent*) sesuai dengan peraturan perundang-undangan tercatat di rekam medik.

Pasal 11

- (1) Persetujuan umum dan pendokumentasiannya dalam rekam medis pasien di luar tindakan yang membutuhkan persetujuan khusus (*informed consent*) tersendiri.
- (2) Persetujuan Umum diperoleh pasien saat akan menjalani rawat Inap.
- (3) Persetujuan umum (*general consent*) diminta saat pertama kali pasien masuk rawat jalan atau setiap masuk rawat inap.
- (4) Pasien dan atau keluarga diminta untuk membaca, lalu menandatangani persetujuan umum (*general consent*).

Pasal 12

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 01 Desember 2025
PLT Direktur RS Prima Husada Malang



dr. Resti Lestantini, M.Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA MALANG
NOMOR 1083.7/I-PND/DIR/XII/2025
TENTANG
PANDUAN PERSETUJUAN TINDAKAN
KEDOKTERAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Informasi merupakan hak yang harus diperoleh setiap orang sebagai hak asasi seorang pasien atau keluarga pasien. Berdasarkan informasi dari persetujuan tindakan kedokteran itulah kemudian pasien atau keluarga pasien dapat mengambil keputusan suatu tindakan medik yang akan dilakukan pada diri atau keluarganya. Prinsip informed consent tersebut memuat pengakuan bahwa yang bersangkutan telah diberi informasi serta telah memahami sepenuhnya dan selanjutnya menyetujui tindakan medik yang disarankan oleh dokter.

1.2 Maksud dan Tujuan

1.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Panduan Penjelasan Tindakan Kedokteran adalah untuk digunakan sebagai panduan atau acuan bagi para Profesional Pemberi Asuhan (PPA) dalam memberikan penjelasan tindakan kedokteran

1.2.2 Tujuan

Panduan Penjelasan Tindakan Kedokteran bertujuan agar dijadikan acuan bagi seluruh Dokter, dokter gigi, dan seluruh tenaga kesehatan Rumah Sakit Prima Husada dalam melaksanakan ketentuan tentang persetujuan tindakan kedokteran.

1.3 Ruang Lingkup

Persetujuan Tindakan Kedokteran (informed Consent) adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekatnya setelah mendapatkan penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.

1.4 Pengertian

1. Persetujuan tindakan kedokteran adalah persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarga terdekat setelah mendapat penjelasan secara lengkap mengenai tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang akan dilakukan terhadap pasien.
2. Tindakan kedokteran atau kedokteran gigi yang selanjutnya disebut tindakan kedokteran adalah suatu tindakan medis berupa preventif, diagnostik, terapeutik atau rehabilitatif yang dilakukan oleh dokter atau dokter gigi terhadap pasien.

-
3. Tindakan Invasif adalah suatu tindakan medis yang langsung dapat mempengaruhi keutuhan jaringan tubuh pasien.
 4. Tindakan kedokteran yang mengandung risiko tinggi adalah tindakan medis yang berdasarkan tingkat probabilitas tertentu, dapat mengakibatkan kematian atau kecacatan.
 5. Dokter dan dokter gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi dan dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 6. Pasien yang kompeten adalah pasien dewasa atau bukan anak menurut peraturan perundang-undangan atau telah/pernah menikah, tidak terganggu kesadaran fisiknya, mampu berkomunikasi secara wajar, tidak mengalami kemunduran perkembangan (retardasi) mental dan tidak mengalami penyakit mental sehingga mampu membuat keputusan secara bebas.
 7. Pasien gawat darurat adalah pasien yang tiba-tiba berada dalam keadaan gawat darurat atau akan menjadi gawat dan terancam nyawanya atau anggota badannya (akan menjadi cacat) bila tidak mendapat pertolongan secepatnya.
 8. Keluarga terdekat adalah suami atau istri, ayah atau ibu kandung, anak-anak kandung, saudara-saudara kandung atau pengampunya.
 - a. Ayah
Ayah Kandung, termasuk “ayah” adalah ayah angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat.
 - b. Ibu
Ibu kandung, termasuk “ibu” adalah ibu angkat yang ditetapkan berdasarkan penetapan pengadilan atau berdasarkan hukum adat.
 - c. Suami
Seorang laki-laki yang dalam ikatan perkawinan dengan perempuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - d. Istri
Seorang perempuan yang dalam ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila yang bersangkutan mempunyai lebih dari 1 (satu) istri, persetujuan/ penolakan dapat dilakukan oleh salah satu dari mereka.
 - e. Wali
Adalah orang yang menurut hukum menggantikan orang lain yang belum dewasa untuk mewakilinya dalam melakukan perbuatan hukum atau orang yang menurut hukum menggantikan kedudukan orang tua.
 - f. Induk Semang
Adalah orang yang berkewajiban untuk mengawasi serta ikut bertanggung jawab terhadap pribadi orang lain, seperti pemimpin asrama dari anak perantauan atau kepala rumah tangga dari seorang pembantu rumah tangga yang belum dewasa.

BAB II KETENTUAN

2.1 Penggunaan Persetujuan tertulis

- 1.1.1. Bila tindakan terapeutik bersifat kompleks atau menyangkut risiko atau efek samping yang bermakna.
- 1.1.2. Bila tindakan kedokteran tersebut bukan dalam rangka terapi
- 1.1.3. Bila tindakan kedokteran tersebut memiliki dampak yang bermakna bagi kedudukan kepegawaian atau kehidupan pribadi dan sosial pasien
- 1.1.4. Bila tindakan yang dilakukan adalah bagian dari suatu penelitian.

2.2 Isi Persetujuan Tindakan

2.2.1 Penjelasan tentang tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya mencakup:

- a) Diagnosis dan tata cara tindakan kedokteran;
- b) Tujuan tindakan kedokteran yang dilakukan;
- c) Alternatif tindakan lain, dan risikonya;
- d) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi; dan
- e) Prognosis terhadap tindakan yang dilakukan.
- f) Perkiraan pembiayaan.

2.2.2 Penjelasan tentang diagnosis dan keadaan kesehatan pasien dapat meliputi:

- a) Temuan klinis dari hasil pemeriksaan medis hingga saat tersebut;
- b) Diagnosis penyakit, atau dalam hal belum dapat ditegakkan, maka sekurang- kurangnya diagnosis kerja dan diagnosis banding;
- c) Indikasi atau keadaan klinis pasien yang membutuhkan dilakukannya tindakan kedokteran;
- d) Prognosis apabila dilakukan tindakan dan apabila tidak dilakukan tindakan.

2.2.3 Penjelasan tentang tindakan kedokteran yang dilakukan meliputi:

- a) Tujuan tindakan kedokteran yang dapat berupa tujuan preventif, diagnostik, terapeutik, ataupun rehabilitatif.
- b) Tata cara pelaksanaan tindakan apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, serta efek samping atau ketidaknyamanan yang mungkin terjadi.
- c) Alternatif tindakan lain berikut kelebihan dan kekurangannya dibandingkan dengan tindakan yang direncanakan.
- d) Risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi pada masing-masing alternatif tindakan.
- e) Perluasan tindakan yang mungkin dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat akibat risiko dan komplikasi tersebut atau keadaan tak terduga lainnya.

2.2.4 Penjelasan tentang risiko dan komplikasi tindakan kedokteran adalah semua risiko dan komplikasi yang dapat terjadi mengikuti tindakan kedokteran yang dilakukan, kecuali:

- a) risiko dan komplikasi yang sudah menjadi pengetahuan umum

- b) risiko dan komplikasi yang sangat jarang terjadi atau yang dampaknya sangat ringan
- c) risiko dan komplikasi yang tidak dapat dibayangkan sebelumnya (unforeseeable)

2.2.5 Penjelasan tentang prognosis meliputi:

- a) Prognosis tentang hidup-matinya (ad vitam);
- b) Prognosis tentang fungsinya (ad functionam);
- c) Prognosis tentang kesembuhan (ad sanationam).

2.3 Persetujuan dan Penjelasan Tindakan Kedokteran

1. Memperoleh informasi dan penjelasan merupakan hak pasien dan sebaliknya memberikan informasi dan penjelasan adalah kewajiban dokter atau dokter gigi.
2. Pelaksanaan Penjelasan Tindakan Kedokteran dianggap benar jika memenuhi persyaratan di bawah ini:
 - a. Persetujuan atau penolakan

3. Kewajiban memberikan informasi dan penjelasan

Dalam hal dokter atau dokter gigi yang merawat pasien atau salah satu dokter atau dokter gigi dari tim dokter yang merawatnya, menilai bahwa penjelasan tersebut dapat merugikan kepentingan kesehatan pasien atau pasien menolak diberikan penjelasan, maka dokter atau dokter gigi dapat memberikan penjelasan tersebut kepada keluarga terdekat dengan didampingi oleh seorang tenaga kesehatan lain sebagai saksi. Bila terjadi kesalahan dalam memberikan informasi tanggung jawab berada di tangan dokter atau dokter gigi yang memberikan delegasi.

Penjelasan harus diberikan secara lengkap dengan bahasa yang mudah dimengerti atau cara lain yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman serta dicatat dan didokumentasikan dalam berkas rekam medis oleh dokter atau dokter gigi yang memberikan penjelasan dengan mencantumkan:

- a. tanggal,
- b. waktu,
- c. nama, dan
- d. tanda tangan pemberi penjelasan dan
- e. tanda tangan penerima penjelasan.

Dalam hal terdapat indikasi kemungkinan perluasan tindakan kedokteran, dokter yang akan melakukan tindakan juga harus memberikan penjelasan. Perluasan tindakan kedokteran yang tidak terdapat indikasi sebelumnya, hanya dapat dilakukan untuk menyelamatkan jiwa pasien. Setelah perluasan tindakan kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan, dokter atau dokter gigi harus memberikan penjelasan kepada pasien atau keluarga terdekat.

2.4 Yang berhak memberikan persetujuan

1. Persetujuan diberikan oleh pasien yang kompeten atau keluarga terdekat.
2. Penilaian terhadap kompetensi pasien dilakukan oleh dokter pada saat diperlukan persetujuan

2.5 Ketentuan Pada Situasi Khusus

Tindakan penghentian/penundaan bantuan hidup (withdrawing/withholding life support) pada seorang pasien harus mendapat persetujuan keluarga terdekat pasien.

Persetujuan penghentian/penundaan bantuan hidup oleh keluarga terdekat pasien diberikan setelah keluarga mendapat penjelasan dari tim dokter yang bersangkutan. Persetujuan harus diberikan secara tertulis. Dalam hal tindakan kedokteran harus dilaksanakan sesuai dengan program pemerintah dimana tindakan medik tersebut untuk kepentingan masyarakat banyak, maka persetujuan tindakan kedokteran tidak diperlukan.

2.6 Penolakan Tindakan Kedokteran

Penolakan tindakan kedokteran dapat dilakukan oleh pasien dan/atau keluarga terdekatnya setelah menerima penjelasan tentang tindakan kedokteran yang akan dilakukan.

Penolakan tindakan kedokteran harus dilakukan secara tertulis.

Akibat penolakan tindakan kedokteran menjadi tanggung jawab pasien.

Penolakan tindakan kedokteran tidak memutuskan hubungan dokter dan pasien.

2.7 Masa berlaku persetujuan tindakan kedokteran

Tidak ada satu ketentuan pun yang mengatur tentang lama keberlakuan suatu persetujuan tindakan kedokteran. Teori menyatakan bahwa suatu persetujuan akan tetap sah sampai dicabut kembali oleh pemberi persetujuan atau pasien. Namun demikian, bila informasi baru muncul, misalnya tentang adanya efek samping atau alternatif tindakan yang baru, maka pasien harus diberitahu dan persetujuannya dikonfirmasi lagi. Apabila terdapat jeda waktu antara saat pemberian persetujuan hingga dilakukannya tindakan, maka langkah lebih baik apabila ditanyakan kembali apakah persetujuan tersebut masih berlaku. Hal-hal tersebut pasti juga akan membantu pasien, terutama bagi mereka yang sejak awal memang masih ragu-ragu atau masih memiliki pertanyaan.

BAB III TATA LAKSANA

Rumah Sakit menetapkan Batasan yang jelas untuk ;

1. Menerapkan proses bagaimana persetujuan umum didokumentasikan dalam rekam medis pasien.
2. Pasien dan keluarga diberikan informasi mengenai pemeriksaan, tindakan, dan pengobatan yang memerlukan consent.
3. Pasien menerima informasi mengenai kemungkinan keterlibatan tenaga Kesehatan dalam proses asuhan pelayanan pasien

3.1 Pemberian Informasi Kepada Pasien

Dengan mengacu kepada kepustakaan, KKI melalui buku manual ini memberikan 12 kunci informasi yang sebaiknya diberikan kepada pasien :

1. Diagnosis dan prognosis secara rinci dan juga prognosis apabila tidak diobati
2. Ketidakpastian tentang diagnosis (diagnosis kerja dan diagnosis banding) termasuk pilihan pemeriksaan lanjutan sebelum dilakukan pengobatan
3. Pilihan pengobatan atau penatalaksanaan terhadap kondisi kesehatannya, termasuk pilihan untuk tidak diobati
4. Tujuan dari rencana pemeriksaan atau pengobatan; rincian dari prosedur atau pengobatan yang dilaksanakan, termasuk tindakan subsider seperti penanganan nyeri, bagaimana pasien seharusnya mempersiapkan diri, rincian apa yang akan dialami pasien selama dan sesudah tindakan, termasuk efek samping yang biasa terjadi dan yang serius
5. Untuk setiap pilihan tindakan, diperlukan keterangan tentang kelebihan/keuntungan dan tingkat kemungkinan keberhasilannya, dan diskusi tentang kemungkinan risiko yang serius atau sering terjadi, dan perubahan gaya hidup sebagai akibat dari tindakan tersebut
6. Nyatakan bila rencana pengobatan tersebut adalah upaya yang masih eksperimental
7. Bagaimana dan kapan kondisi pasien dan akibat sampingannya akan dimonitor atau dinilai kembali
8. Nama dokter yang bertanggungjawab secara keseluruhan untuk pengobatan tersebut, serta bila mungkin nama-nama anggota tim lainnya
9. Bila melibatkan dokter yang sedang mengikuti pelatihan atau pendidikan, maka sebaiknya dijelaskan peranannya di dalam rangkaian tindakan yang akan dilakukan
10. Mengingatkan kembali bahwa pasien dapat mengubah pendapatnya setiap waktu. Bila hal itu dilakukan maka pasien bertanggungjawab penuh atas konsekuensi pembatalan tersebut.
11. Mengingatkan bahwa pasien berhak memperoleh pendapat kedua dari dokter lain
12. Bila memungkinkan, juga diberitahu tentang perincian biaya.

3.2 Cara Pemberian informasi

Pasien dan keluarga diberikan informasi mengenai pemeriksaan , tindakan dan pengobatan mana yang memerlukan persetujuan dan bagaimana menerak dapat memberikan persetujuan. Edukasi diberikan oleh staf rumah sakit yang berkompeten dan merupakan bagian dari proses untuk mendapatkan persetujuan.

Bagaimana cara anda memberikan informasi kepada pasien sama pentingnya dengan informasi apa yang akan anda berikan kepada pasien. Pasien tidak dapat memberikan persetujuan yang sah kecuali mereka telah diberitahu sebelumnya. Untuk membantu mereka membuat keputusan anda diharapkan mempertimbangkan hal-hal di bawah ini:

1. Informasi diberikan dalam konteks nilai, budaya dan latar belakang mereka. Sehingga menghadirkan seorang interpreter mungkin merupakan suatu sikap yang penting, baik dia seorang profesional ataupun salah seorang anggota keluarga. Ingat bahwa dibutuhkan persetujuan pasien terlebih dahulu dalam mengikutsertakan interpreter bila hal yang akan didiskusikan merupakan hal yang bersifat pribadi.
2. Dapat menggunakan alat bantu, seperti leaflet atau bentuk publikasi lain apabila hal itu dapat membantu memberikan informasi yang bersifat rinci. Pastikan bahwa alat bantu tersebut sudah berdasarkan informasi yang terakhir. Misalnya, sebuah leaflet yang menjelaskan tentang prosedur yang umum. Leaflet tersebut akan membuat jelas kepada pasien karena dapat ia bawa pulang dan digunakan untuk berpikir lebih lanjut, tetapi jangan sampai mengakibatkan tidak ada diskusi.
3. Apabila dapat membantu, tawarkan kepada pasien untuk membawa keluarga atau teman dalam diskusi atau membuat rekaman dengan tape recorder
4. Memastikan bahwa informasi yang membuat pasien tertekan (distress) agar diberikan dengan cara yang sensitif dan empati. Rujuk mereka untuk konseling bila diperlukan
5. Mengikutsertakan salah satu anggota tim pelayanan kesehatan dalam diskusi, misalnya perawat, baik untuk memberikan dukungan kepada pasien maupun untuk turut membantu memberikan penjelasan
6. Menjawab semua pertanyaan pasien dengan benar dan jelas.
7. Memberikan cukup waktu bagi pasien untuk memahami informasi yang diberikan, dan kesempatan bertanya tentang hal-hal yang bersifat klarifikasi, sebelum kemudian diminta membuat keputusan

3.3 Penyampaian keputusan

Secara tradisional mereka dapat menyampaikannya melalui beberapa cara:

1. Persetujuan yang bersifat tersirat atau tidak dinyatakan (implied consent).
2. Pasien dapat saja melakukan gerakan tubuh yang menyatakan bahwa mereka “mempersilahkan” dokter melaksanakan tindakan kedokteran yang dimaksud. Misalnya adalah bila pasien menggulung lengan bajunya dan menyodorkan lengannya pada saat dokter menanyakan mau atau tidaknya ia diukur tekanan darahnya atau saat ia akan dilakukan pengambilan darah vena untuk pemeriksaan laboratorium.
3. Persetujuan yang dinyatakan (express consent).
4. Pasien dapat memberikan persetujuan dengan menyatakannya secara lisan (oral consent) ataupun tertulis (written consent).

Daftar tindakan yang dikembangkan Bersama melalui oleh para dokter yang diberikan perawatan atau melakukan tindakan. Daftar ini meliputi semua tindakan dan perawatan yang disiapkan untuk pasien rawat jalan ataupun rawat inap, meliputi sebagai berikut :

- a. Rumah Sakit menerapkan proses bagi pasien untuk mendapatkan informed consent.
- b. Pemberian informed Consent dilakukan oleh staf yang kompeten dan diberikan dengan cara dan Bahasa yang mudah di pahami pasien.
- c. Rumah Sakit memiliki daftar tindakan Invasif , pemeriksaan dan terapi tambahan yang memerlukan Informed Consent.

Table 3.1 Daftar Pemberian Informasi Persetujuan Tindakan

Unit	Tindakan pembedahan	Anastesi & Sedasi
Ruang operasi		
Operasi obgyn	Sectio Caesar (v)	RA
	Histerektomi (v)	GA / RA
	Kistektomi (v)	GA / RA
	Kontrasepsi	GA / RA
	Operasi KET	GA / RA
Operasi bedah umum	Tiroidectomi	GA
	Apendicitis	GA
	Herniotomi	GA
	Debridement	GA
	Vesikolitotomi	GA
	Eksisi Soft Tissue	GA
	Hemoroidektomi	GA
	Cholisistectomy	GA
Operasi Ortho	ORIF	GA / RA
	Pinning	GA / RA
	Remove Implant	GA / RA
Operasi Urologi	URS	RA
	TURP	RA
	TURB	RA
	Vesicolithotripsy	RA
	Vesicolithotomy	RA
Operasi Mata	Katarak	LA
	Pacho	LA
	STT	GA
Operasi THT	Tonsillectomy with adenoidectomy	GA
ODC	Insisi	LA
	Eksisi	LA
	Ekstirpasi	LA
	Aff DJ Stent	LA
	Removal Wire	LA
	Curretage	LA
	ESWL	LA
	Reposisi	LA
FNAB		
Poli Gigi	Pencabutan gigi	LA
	Gingivectomy	LA
Poli Rawat Jalan	Ekstraksi kuku	LA
	sirkumsisi	LA
	hecting	LA
	Injeksi Hemorroid	
	Treadmill	
	Injeksi Endrolin	
Radiologi	IVP	
Gawat Darurat	Heacting	
	Ekstraksi kuku	
ICU	Pemasangan ventilator	
KKP	Curretage	
	Drip Oksitosin	



	Vakum Extraksi	
	Persalinan Sungsang	
	Persalinan Normal	
	Open biopsy	
NGT		
Kateter		
Tindakan risiko tinggi	Pemberian cairan MgSO ₄	

BAB IV PENUTUP

Panduan Persetujuan Tindakan kedokteran ini dapat dijadikan acuan oleh Tim Pelayanan dalam memenuhi hak dan kewajiban pasien selama di rawat di Rumah Sakit Prima Husada, sehingga diharapkan dapat dilakukan pelayanan secara cepat, cermat dan berkualitas.

Langkah selanjutnya adalah mendorong pimpinan instansi atau unit kerja untuk memberikan hak pasien dan keluarga guna memperbaiki mutu pelayanan di unit kerjanya.

Ditetapkan di Malang
Pada Tanggal 01 Desember 2025
PLT Direktur RS Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M.Kes